

唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系构建

赖政东, 周桥桥, 胡惠菊, 唐启群

华北理工大学护理与康复学院, 河北唐山, 063210

摘要 目的:构建唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系,为失智老年人护理员的培养、考核和能力评估提供参考依据。**方法:**通过文献回顾、质性访谈,初步构建唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系。于2024年9—10月,采用德尔菲专家函询法选取从事老年护理教育、失智症管理、养老机构管理等领域工作的18名专家进行问卷函询,运用层次分析法确定各级指标权重。**结果:**2轮函询问卷的有效回收率分别为90%和100%,专家权威系数分别为0.825和0.842,肯德尔和谐系数分别为0.222和0.236($P<0.05$)。最终确立的唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系包含5项一级指标(理论知识、专业技能、通用能力、职业态度和个人特质)、17项二级指标(老年照护基础知识、失智症相关理论知识、职业相关法律知识、生活照护技能、精神行为症状护理技能、康复照护技能、沟通能力、思维能力、协作能力、学习能力、角色定位、职业道德、职业礼仪、身体素质、心理素质、自身品质和自我管理)和68项三级指标。**结论:**本研究构建的唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系内容合理,构建过程科学、可靠,评价指标具有全面性、可行性和针对性,对失智老年人护理员照护胜任力的评价及培训具有指导意义。

关键词 老年健康;失智老年人;照护胜任力;护理员;指标体系;唐山

中图分类号: R-05;R192.6

文献标识码: A

DOI:10.13723/j.yxysh.2026.05.010

文章编号: 1006-5563(2026)05-0070-09

Construction of Care Competence Evaluation Index System of Caregivers for Older Adults with Dementia in Elderly Care Institutions in Tangshan

LAI Zhengdong et al

College of Nursing and Rehabilitation, North China University of Science and Technology, Tangshan, Hebei, 063210, China

Abstract Objective: To establish an evaluation index system for the care competency of caregivers for older adults with dementia in elderly care institutions in Tangshan, so as to provide a reference basis for the training, assessment, and competency evaluation of such caregivers. **Methods:** Through literature review and qualitative interviews, a preliminary evaluation index system for the competency of caregivers for older adults with dementia in elderly care institutions in Tangshan was established. From September to October 2024, the Delphi expert questionnaire method was employed to select 18 experts from fields including geriatric nursing education, dementia management and elderly care institution management. A questionnaire survey was conducted, and the analytic hierarchy process was used to determine the weight of indicators at each level. **Results:** The valid response rates for the two rounds of questionnaires were 90% and 100%, respectively. The expert authority coefficients were 0.825 and 0.842, with Kendall's coefficient of concordance at 0.222 and 0.236 ($P<0.05$). The finalized evaluation index system for the care competency of caregivers for older adults with dementia in elderly care institutions in Tangshan included 5 first-level indicators (theoretical knowledge, professional skills, general competencies, professional attitude, and personal characteristics), 17 second-level indicators (basic knowledge of elderly care, dementia-related theoretical knowledge, occupational legal knowledge, daily living care skills, behav-

基金项目:2024年河北省社会科学基金青年项目,编号为HB24GL019

通讯作者:胡惠菊,15512580723@163.com

ioral and psychological symptom management skills, rehabilitation care skills, communication ability, thinking ability, collaboration ability, learning ability, role positioning, professional ethics, occupational etiquette, physical fitness, psychological fitness, personal qualities, and self-management), and 68 third-level indicators. **Conclusion:** The competency evaluation index system for caregivers for older adults with dementia in elderly care institutions in Tangshan developed in this study features a well-structured content and a scientifically sound and reliable construction process, and evaluation indicators are comprehensive, feasible and targeted. It provides valuable guidance for assessing and training the care competencies of caregivers for older adults with dementia.

Key Words Elderly Health; Older Adults with Dementia; Care Competence; Nursing Staff; Indicator System; Tangshan

胜任力最早由哈佛大学教授 McClelland 在 1973 年提出,他指出工作成功与否的关键并非智力,而应深入考察个体的动机、特质等深层因素,并首次将胜任力界定为与工作绩效等关键成果直接相关的知识、技能、能力、特质与动机的集合^[1]。作为胜任力理论的核心工具,胜任力模型整合了各要素,用以识别特定岗位成功所需的关键能力。其中,冰山模型是应用最广泛的经典模型之一,它将胜任力划分为易于观察和培养的知识与技能和难以触及却更为根本的特质与动机等内隐要素两大层次^[2]。该模型已在医学领域得到广泛应用,为医生、护理人员等不同岗位的胜任力评估提供了客观、全面的工具^[3-5]。

失智症是一种以记忆和思维等认知功能逐渐受损为特征的多领域障碍综合征,以老年痴呆最常见^[6]。该病症是致使老年群体丧失自理能力、高度依赖他人及入住养老机构的关键诱因之一^[7],其危害性已位居威胁老年人健康疾病的第 5 位,仅次于心脑血管及慢性呼吸系统疾病^[8]。依据《北京市养老机构失智老年人照护服务规范(2022 年版)》《重庆市养老机构失智老年人照护服务规范(2023 年版)》等相关标准,失智老年人是指因脑部伤害或疾病导致的渐进性认知功能退化,且退化程度远高于正常老化的老年人群体,这一群体通常表现为记忆力减退、注意力障碍、语言障碍、执行功能受损及行为异常等症状,严重时可能无法分辨人事时地物;失智老年人护理员照护是指由护理员为失智老年人提供的生活照料、异常精神行为照护及功能促进等方面的服务。随着我国人口老龄化进程的加快,失智老年人的长期照护问题已成为亟待解决的重大公共卫生议题^[9]。

据《柳叶刀》杂志报道,全球每 3 秒就有 1 人被诊断为失智症^[10]。而我国 60 岁及以上的失智症患者数量已达到 1507 万例,占老年人口比例的 7%,居世界首位^[11];唐山市人民政府新闻发布会指出唐山市失智老年人约 6.5 万人,占唐山市老年人口比例的 3.82%。庞大的失智群体不仅给家庭带来沉重的照护与经济负担,也对唐山市养老体系构成了严峻挑

战。养老机构作为社会化养老体系的核心载体,在应对人口老龄化、缓解家庭照护压力方面发挥着不可或缺的作用^[12],目前唐山市拥有养老机构 344 家,养老床位 3.74 万张,机构规模与床位数均位居全省首位。2025 年,国家卫生健康委在《医养结合示范项目工作方案》中指出,应加强医养结合机构建设,要求入住失能和失智老年人占比超过 65%,并将失智老年人纳入机构服务的重点对象,鼓励机构提供专业化照护。2019 年,人力资源社会保障部和民政部发布《养老护理员国家职业技能标准》,将护理员界定为承担养老机构内老年人日常生活照料及辅助护理工作的专业人员,并明确提出加强护理员对失智老年人的照护能力。然而,我国失智症专业照护服务尚处起步阶段,养老机构在护理员的专业素养、准入标准、系统培训及效果评价等环节仍存在明显短板,导致服务供给与实际需求之间存在巨大鸿沟^[13]。研究表明,对护理员进行系统化失智症照护能力培训,可以实现提升失智老年人生活质量和缓解护理员职业压力的双赢局面^[14]。因此,亟需建立与完善符合当前养老机构发展实际的失智老年人护理员照护胜任力评价体系。

关于护理人员胜任力的探讨,国内外学界已积累了丰富的研究成果,尤其在失智症照护领域,已形成一系列具有指导意义的实践标准。国际上,美国、英国、加拿大等国走在前列,分别发布了各具特色的胜任力框架。美国的标准强调 7 大实践领域,从沟通到痛苦行为管理,覆盖了照护的全过程^[15];英国失智症协会则聚焦护士角色,提出了包含人文关怀与批判性思维在内的 6 个核心维度^[16];加拿大的框架则兼顾实践能力与职业态度,体现了对综合素质的重视^[17]。国内研究方面,我国学者在借鉴国际经验的基础上,结合本土情境进行了积极探索。标志性成果是 2016 年提出的“知识—态度—技能”三位一体的老年性痴呆照护胜任力要求^[18]。在此基础上,后续研究不断深化,针对初级养老护理员、医疗护理员等不同岗位的胜任力模型与评价工具被陆续开发出来^[19-21]。综上所述,现有文献呈现出“宏观

有余,微观不足”的格局。国外先行研究虽细致,但其研究对象多为医院专科护士,未能充分回应养老机构失智老年人护理员的独特需求。而国内研究则倾向于构建普适性的机构护理员评价体系,指标设计较为宽泛,未能深入到失智症照护的特定场景与核心技能,缺乏针对性。基于此,本研究以冰山模型为理论指导,采用文献回顾、质性研究、德尔菲法及层次分析法相结合的研究路径,系统构建一套适用于唐山市养老机构的失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系,为失智老年人护理员的培养、考核和能力评估提供参考依据。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

1.1.1 文献检索。检索中国知网、万方、维普、中国生物医学文献数据库、PubMed、Web of Science、CINAHL、Wiley Online Library 等国内外文献数据库。检索时间从建库至 2024 年 6 月 20 日,中文检索词为“失智症”“老年痴呆”“阿尔茨海默病”“护理员”“核心能力”“胜任力”等,英文检索词为“dementia”“Alzheimer disease”“care worker”“competency”“competence”等。通过数据库检索最初获得 608 篇文献,排除重复文献 189 篇后剩余 419 篇,阅读题目和摘要排除 387 篇后剩余 32 篇,阅读全文后排除无可用信息论文 17 篇,经反复阅读筛选最终纳入 15 篇文献。结合《养老护理员国家职业技能标准(2019 年版)》《南京市养老机构失智老年人照护服务规范(2021 年版)》《北京市养老机构失智老年人照护服务规范(2022 年版)》《重庆市养老机构失智老年人照护服务规范(2023 年版)》等相关标准和规范,并按照胜任力冰山模型进行分类和整理,归纳总结相关照护胜任力特征。

1.1.2 质性访谈。采用目的抽样法,基于信息饱和原则,于 2024 年 8—9 月,分别选取唐山市一家大型养老机构和一家小型养老机构的 12 名养老机构管理者和 15 名失智老年人护理员进行访谈。养老机构管理者纳入标准:直接从事养老护理质量管理工作;管理工作年限 ≥ 1 年;知情同意,自愿参与本研究。排除标准:外来进修和学习的管理者。养老机构护理员纳入标准:照护失智老年人 3 个月以上;知情同意,自愿参与本研究。排除标准:外来进修、学习及非正式照护人员;近 2 个月经历过重大生活事件、影响情绪状态者。基于系统的文献回顾和课题组内部研讨后初步拟定了访谈提纲草案,经专家审核及对 2

名管理者和 2 名护理员预访谈后修改,确定最终的访谈提纲。管理者提纲:失智老年人护理员的核心工作职责是什么;招聘时优先考察护理员的哪些特质;实践中失智老年人护理员应具备哪些关键素质;失智老年人护理员未来需要重点培养和提升的能力。护理员提纲:日常工作内容是什么;工作中遇到过什么挑战,是如何应对的;工作中的成就感来源于什么;有什么优化照护服务的建议;在照护失智老年人的时候侧重点有什么不同;觉得自身能力还需要得到怎样的提升。在访谈结束后 24 小时内,课题组对访谈录音材料及时进行转录、分类和汇总,并返回给受访者确认内容的真实性。

1.1.3 专家遴选。于 2024 年 10—11 月,采用目的抽样法,从医院、高校和养老机构选择具备失智症照护相关知识与实践经验的 20 名专家进行函询。为确保研究结果的广泛适用性与权威性,本次专家函询的样本在地域分布上力求均衡。所邀请的专家覆盖了我国东部、中部及西部 3 大区域,具体来自北京、天津、河北、广东、江西及贵州 6 个省份。专家遴选标准如下。①养老机构管理者:具备专科及以上学历,从事护理质量管理工作 ≥ 5 年。②老年护理教育者:具备本科及以上学历,从事老年护理教学工作 ≥ 5 年。③临床失智症护理管理专家:具备本科及以上学历,工作年限不少于 5 年。

1.2 研究方法

1.2.1 理论基础。本研究的理论框架融合了 McClelland 的冰山模型和 Watson 的 DNA 双螺旋结构模型^[1,22]。冰山模型形象地将胜任力划分为“水上”部分的知识与技能等外显要素和“水下”部分的特质和动机等内隐要素^[23-24]。该模型因其结构清晰且层次分明,已成为评估个体素质的权威理论工具,在管理领域影响深远^[25]。DNA 双螺旋模型则以其双链并行、相互支撑的稳定结构,为胜任力要素的协同发展提供了绝佳的理论隐喻。该模型指出,一个完整的胜任力体系应由两个核心维度构成,二者相互缠绕、缺一不可,这一理念已在医护人员、教师等专业人才的胜任力研究中成功应用^[26-27]。因此,本研究所构建的唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力模型,亦由两条核心“主链”构成:一条是由理论知识与专业技能构成的外显胜任力链;另一条则是由职业态度与个人特质组成的内隐胜任力链。这两条链通过人才选拔、系统培训、绩效考核等实践环节紧密相连,形成稳固而动态的整体结构,并共同驱动失智老年人照护服务质量的提升。

1.2.2 德尔菲法。首先,基于前期文献分析与质性访谈结果,研究小组通过多轮内部研讨与修订,初步构建了包含5项一级指标、16项二级指标及73项三级指标的胜任力评价指标池。依据此指标池,设计结构化专家函询问卷。问卷内容涵盖:研究背景与目的、填表指导、专家基本信息、指标重要性评价表及专家权威程度自评表。各指标的重要性评价采用Likert 5级评分法,并为每个条目增设“修改意见”与“新增建议”栏,以收集专家的质性反馈。问卷通过电子邮件形式发放与回收。为确保函询结果的科学性与可靠性,本研究从专家积极性、权威性与意见协调程度3个维度进行质量控制。

1.2.3 指标筛选。指标筛选遵循量化与质性相结合的原则。量化筛选标准为:保留重要性赋值均数>3.5且变异系数<0.25的指标。对于未达标准的指标,结合专家提出的具体修改或删除意见进行综合研判。经过两轮专家函询,专家意见趋于收敛,最终确立了包含5个一级指标、17个二级指标和68个三级指标的唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系。

1.2.4 层次分析法。本研究采用层次分析法计算指标权重。邀请相关专家依据Satty 1-9标度法,对同一层级内的指标进行两两比较,构建判断矩阵。随后,运用Yaahp 10.0软件计算各指标的权重向量,并进行一致性检验。对于一致性比率>0.1的判断矩阵,视为专家判断逻辑不一致,将其剔除或请专家重新评估;将通过一致性检验CR值≤0.1的有效判断矩阵结果纳入最终权重计算。

1.3 统计学方法

本研究采用SPSS 24.0和Excel 2019软件进行数据录入与分析。计量资料以均数和标准差描述,计数资料以频数和百分比描述。专家积极性用问卷有效回收率表示,专家意见集中程度用各指标评价的均数表示,专家权威程度系数为判断系数与熟悉程度系数的算术平均数,专家意见协调程度用变异系数和肯德尔和谐系数表示。层次分析法的数据处理与权重计算通过Yaahp 10.0软件完成。

2 结果

2.1 专家基本情况

本研究共18名专家参与了2轮函询,其中老年护理专家9名(占50.0%),临床护理专家5名(占27.8%),社区护理专家2名(占11.1%),养老机构管理专家2名(占11.1%);专家年龄为33-60岁,平均

年龄为(44.93±8.21)岁;专家学历构成中,硕士及以上学历者16名(占88.9%),本科学历者2名(占11.1%);专家工作年限为10-40年,平均工作年限为(21.21±9.28)年。见表1。

表1 专家基本情况(n=18)

项目	人数	占比/%
性别		
男	2	11.1
女	16	88.9
年龄/岁		
30-39	5	27.8
40-49	8	44.4
50-60	5	27.8
学历		
本科	2	11.1
硕士	11	61.1
博士	5	27.8
职称		
中级	3	16.7
副高级	8	44.4
正高级	7	38.9
工作年限/年		
10-19	9	50.0
20-29	6	33.3
≥30	3	16.7
工作领域		
老年护理	9	50.0
临床护理	5	27.8
社区护理	2	11.1
养老机构管理	2	11.1

2.2 专家的积极性及权威性

本研究第一轮共向20位专家发放函询问卷,回收有效问卷18份,有效回收率为90.0%。第二轮向参与第一轮的18位专家继续发放问卷,全部有效回收,有效回收率达100.0%。本研究中两轮函询专家权威系数分别为0.825和0.842,均高于0.70。这表明研究收集的专家意见具有较高的权威性与参考价值,从而保障了函询结果的可靠性。

2.3 专家意见集中程度及协调程度

两轮函询中,所有指标的重要性评分均值均大于3.5分,且专家认可率均大于50%,说明专家意见较集中。协调系数越接近1则专家意见协调性越好,本研究结果显示,第一轮函询各级指标的协调系

数在 0.222–0.271, 第二轮提升至 0.236–0.301 (均 $P < 0.001$), 表明 2 轮专家函询意见均有较高的一致性。见表 2。

表 2 专家意见协调程度

项目	第一轮			第二轮		
	W	χ^2	P	W	χ^2	P
一级指标	0.271	19.504	<0.001	0.301	21.679	<0.001
二级指标	0.236	63.687	<0.001	0.268	77.319	<0.001
三级指标	0.226	293.460	<0.001	0.241	294.637	<0.001
总评价指标	0.222	371.923	<0.001	0.236	382.696	<0.001

2.4 专家咨询结果

经过第一轮专家咨询, 结合专家意见和工作组讨论结果, 对指标进行了如下修改。删除了 7 个三级指标, 修改了 2 个二级指标和 6 个三级指标, 增加了 1 个二级指标“职业相关法律知识”和 1 个三级指标“能够定期引导失智老年人回忆过去, 以维持其认知功能和情感联系”。在第二轮专家咨询中, 删除了 2 个三级指标, 合并了 2 个三级指标, 修改了 7 个三级指标, 新增了 2 个三级指标, 即“自信心和相信自己能够胜任护理员相应的护理工作”和“在护理过程中的自我保护意识和采取相应预防措施的能力”。最终包含 5 个一级指标、17 个二级指标、68 个三级指标。见表 3。

2.5 指标权重结果

本研究一级指标、二级指标和三级指标的一致性检验 CR 值均小于 0.1, 通过一致性检验。其中一级指标理论知识、专业技能、通用能力、职业态度和个人特质的权重依次为: 0.1622、0.2860、0.1984、0.1780 和 0.1755。见表 3。

3 讨论

3.1 本研究构建的唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价体系具有科学性和可靠性

唐山市作为失智老年群体数量众多的城市, 其养老机构对专业失智症照护的需求日益迫切。尽管《医养结合示范项目工作方案》已明确将失智老年人列为机构服务的重点, 但作为一线照护执行者的护理员, 其专业胜任力尚未得到足够重视。当前, 我国养老护理员普遍存在失智症相关知识与技能的短板, 且针对该群体的培训体系尚不成熟^[28]。现有研究在构建养老机构护理员胜任力模型时存在明显局限: 其一, 研究对象多为全体护理员, 缺乏对失智老年人护理员这一特殊群体的针对性^[19]; 其二, 研究

方法多依赖文献回顾与德尔菲法, 缺少实地调研, 导致模型易受专家主观经验影响, 实际应用性不足^[20]; 其三, 即便借鉴冰山模型, 多数研究也仅涵盖知识、技能、态度 3 个维度, 未能全面反映胜任力的多维性与复杂性^[21]。

为克服上述局限, 本研究在构建唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价体系时, 立足于唐山市养老机构失智老年人护理员胜任力现况, 系统梳理并整合高质量文献, 将其融入以 DNA 双螺旋结构模型与冰山模型为核心的理论框架中, 从而确保指标体系构建的科学性与适用性。该体系不仅契合国家及唐山市对失智老年人护理员照护能力的政策导向, 也与《养老护理员国家职业技能标准》《河北省“十四五”健康老龄化行动计划》等政策文件相呼应。具体体现在以下方面。首先研究对象与方法更具针对性, 本研究聚焦于各类养老机构的失智老年人护理员, 综合运用文献分析、质性访谈与实地调研等多种方法, 深入挖掘其胜任力特征, 为指标体系的构建奠定了坚实的实践基础。其次, 指标构建过程更为严谨规范, 本研究在构建指标体系时采用德尔菲法对来自东、中、西部地区的权威专家进行两轮函询。结果显示, 2 轮专家权威系数分别为 0.825 和 0.842, 表明专家权威性较强, 第 2 轮指标协调系数为 0.236–0.301, 且较第一轮有所提升, 说明专家意见趋于一致^[29]。在此基础上, 运用定量的层次分析法将专家的定性判断量化为权重, 有效降低了主观偏差, 增强了结果的客观性。最后, 指标内容设计更具系统性, 基于冰山模型为理论框架, 本研究构建了一个涵盖理论知识、专业技能、通用能力、职业态度和个人特质 5 个维度的综合评价体系。该体系不仅兼顾了显性与隐性胜任力特征, 还弥补了既往研究中维度单一、结构松散的不足, 为构建一套科学、系统且符合唐山市养老机构发展需求的失智老年人护理员胜任力评价标准提供了重要参考。

3.2 显性要素“专业技能”是衡量失智老年人护理员照护胜任力最直观的尺度

我国部分省份已有针对养老机构失智老年人照护的地方标准, 例如《北京市养老机构失智老年人照护服务规范(2022 年版)》《重庆市养老机构失智老年人照护服务规范(2023 年版)》和《河北省养老机构失智老年人照护服务规范(2025 年版)》等。这些文件均对失智老年人护理员的照护能力提出了明确要求, 内容覆盖了日常生活照料、精神行为症状应对及认知功能康复训练等方面, 这实质上是对失智老年

表 3 唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系

指标	重要性赋值 ($\bar{x} \pm s$)	变异 系数	满分率/ %	组合 权重
A 理论知识	4.83±0.38	0.08	83.33	0.1622
A1 老年照护基础知识	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0594
A1.1 了解老年人的生理特点、老化过程及改变	5.00±0.00	0.00	100.00	0.0310
A1.2 了解老年人的心理特点、心理问题及需求	4.33±0.77	0.18	50.00	0.0284
A2 失智症相关理论知识	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0741
A2.1 了解失智症的主要特征和症状表现	4.28±0.75	0.18	44.44	0.0259
A2.2 熟悉失智老年人的生活、健康照护等服务知识	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0139
A2.3 掌握失智老年人进食、饮水、营养等基本知识	4.78±0.55	0.11	83.33	0.0242
A2.4 掌握预防失智老年人意外风险和应急处理策略	4.33±0.77	0.18	50.00	0.0102
A3 职业相关法律知识	4.11±0.76	0.18	33.33	0.0286
A3.1 了解《中华人民共和国老年人权益保障法》《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律	4.11±0.76	0.18	33.33	0.0163
A3.2 了解养老机构的管理规范及相关规章制度	4.00±0.77	0.19	27.78	0.0123
B 专业技能	4.28±0.96	0.22	61.11	0.2860
B1 生活照护技能	4.11±0.76	0.18	33.33	0.1121
B1.1 能够按照卫生标准完成居室清扫	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0115
B1.2 能够引导或协助失智老年人进行口腔清洁及仪容修饰	4.28±0.75	0.18	44.44	0.0080
B1.3 能够准确测量并记录失智老年人的生命体征	4.33±0.77	0.18	50.00	0.0343
B1.4 能够准确评估失智老年人的营养状况	4.78±0.43	0.09	77.78	0.0100
B1.5 能够观察并掌握失智老年人的排泄规律,提供及时的如厕提醒或协助	4.33±0.69	0.16	44.44	0.0112
B1.6 能够为失智老年人提供个性化的沐浴支持	4.22±0.88	0.21	50.00	0.0115
B1.7 能够正确、安全地扶抱搬移失智老年人	4.67±0.49	0.10	66.67	0.0048
B1.8 能够准确管理和协助失智老年人用药	4.83±0.51	0.11	88.89	0.0127
B1.9 能够为失智老年人营造良好的睡眠环境	4.11±0.76	0.18	33.33	0.0081
B2 精神行为症状护理技能	4.78±0.65	0.14	88.89	0.1242
B2.1 能够通过倾听为有妄想和猜忌的失智老年人提供情感支持	4.39±0.78	0.18	55.56	0.0170
B2.2 面对有幻觉与错觉的失智老年人,能够聆听老人的倾诉并引导其转移注意力	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0101
B2.3 能够为有昼夜颠倒行为的失智老年人创造适宜的室内环境,帮助其调整生物钟	4.22±0.88	0.21	50.00	0.0108
B2.4 面对有躁动行为的失智老年人,能够陪伴并询问其需求,并引导其回到居室	4.11±0.76	0.18	33.33	0.0123
B2.5 能够采取恰当非药物性的约束措施,以保护有撕扯、攻击行为的失智老年人及其周围人员安全	4.67±0.59	0.13	72.22	0.0130
B2.6 能够耐心地回应失智老年人重复性问题,采取策略以减少老人的焦虑和不安	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0135
B2.7 面对失智老年人的错误行为,能够给予回应和提醒	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0194
B2.8 当失智老年人出现当众脱衣裤的迹象时,能够引导其回房,不指责和激惹老人	4.83±0.38	0.08	83.33	0.0183
B2.9 能够根据失智老年人的身体情况和喜好引导其参与适宜的活动	4.22±0.81	0.19	44.44	0.0099
B3 康复照护技能	4.28±0.75	0.18	44.44	0.0497
B3.1 能够根据失智老年人的生活习惯优化其生活环境(如将老人常用物品放置在其熟悉的位置)	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0224
B3.2 能够定期引导失智老年人回忆过去,以维持其认知功能和情感联系	4.39±0.85	0.19	61.11	0.0089
B3.3 能够为失智老年人提供时间线索,如设置钟表和日历,以帮助其辨识时间	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0046
B3.4 能够通过重复引导和醒目标识,帮助失智老年人识别和记忆日常活动的地点	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0139
C 通用能力	4.44±0.86	0.19	66.67	0.1984
C1 沟通能力	4.72±0.57	0.12	77.78	0.0655
C1.1 能够耐心倾听他人的表达,并及时做出反馈	4.83±0.38	0.08	83.33	0.0166
C1.2 能够做到自我表达准确,避免信息模糊或遗漏	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0179
C1.3 能够根据失智老年人的认知水平,使用适当的称呼	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0098
C1.4 能够运用恰当的沟通技巧,如简化语言或肢体语言与失智老年人进行沟通	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0212

表 3(续)

指标	重要性赋值 ($\bar{x}\pm s$)	变异 系数	满分率/ %	组合 权重
C2 思维能力	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0258
C2.1 能够动态评估和观察失智老年人的异常情况	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0139
C2.2 能够批判性地思考并整合各方意见,以优化照护实践	4.83±0.38	0.08	83.33	0.0118
C3 协作能力	4.17±0.86	0.21	44.44	0.0686
C3.1 能够与同事共同制定和执行照护计划	4.22±0.81	0.19	44.44	0.0241
C3.2 能够与失智老年人家属合作,实现双方信息共享	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0201
C3.3 能够与医务人员密切配合,及时汇报失智老年人的健康问题	4.61±0.61	0.13	66.67	0.0244
C4 学习能力	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0385
C4.1 能够积极参加专业培训,学习新的照护理念和技术	4.17±0.71	0.17	33.33	0.0190
C4.2 能够从日常照护中总结经验教训,并将其应用于未来的照护工作中	4.61±0.61	0.13	66.67	0.0195
D 职业态度	4.89±0.32	0.07	88.89	0.1780
D1 角色定位	4.22±0.88	0.21	50.00	0.1144
D1.1 认同护理员职业,明确自身的职业价值	4.17±0.71	0.17	33.33	0.0645
D1.2 知晓自身的职责范围	4.83±0.38	0.08	83.33	0.0499
D2 职业道德	4.22±0.81	0.19	44.44	0.0455
D2.1 爱岗敬业	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0100
D2.2 遵纪守法	4.61±0.61	0.13	66.67	0.0062
D2.3 平等对待每一位失智老年人	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0074
D2.4 尊重失智老年人的生活习惯、意愿和文化信仰	4.44±0.78	0.18	61.11	0.0085
D2.5 注重隐私保护,不泄露失智老年人的个人信息	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0135
D3 职业礼仪	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0181
D3.1 仪容仪表整洁得体,不佩戴过于夸张的饰品	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0046
D3.2 以友善的态度对待失智老年人	4.22±0.81	0.19	44.44	0.0016
D3.3 举止得体、站立端正、动作轻柔	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0024
D3.4 文明用语、音调温和、语速平缓	4.67±0.69	0.15	77.78	0.0080
D3.5 尊重和关爱失智老年人	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0015
E 个人特质	4.50±0.71	0.16	61.11	0.1755
E1 身体素质	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0457
E1.1 身体健康,能够胜任日常照护工作	4.22±0.81	0.19	44.44	0.0242
E1.2 具备一定的适应力,能够适应不同工作强度	4.17±0.79	0.19	38.89	0.0215
E2 心理素质	4.67±0.69	0.15	77.78	0.0452
E2.1 能够有效调节心理状态,保持积极的工作态度	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0206
E2.2 具有稳定平和的情绪状态,能够控制自己的情绪不受失智老年人情绪波动的影响	4.50±0.71	0.16	61.11	0.0050
E2.3 具备良好的专注力,时刻注意失智老年人的变化和需求	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0196
E3 自身品质	4.11±0.83	0.20	77.78	0.0411
E3.1 为人热情,能够主动了解失智老年人的情况	4.67±0.59	0.13	72.22	0.0049
E3.2 耐心细致,照护失智老年人不厌烦、不急躁	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0048
E3.3 诚实守信,为人正直可靠,做事脚踏实地	4.22±0.73	0.17	38.89	0.0099
E3.4 同理心强,能够站在失智老年人的角度看问题	4.89±0.32	0.07	88.89	0.0065
E3.5 责任心强,对待工作认真负责,坚守岗位	4.17±0.79	0.19	38.89	0.0073
E3.6 自信心强,相信自己能够胜任护理员的照护工作	4.94±0.24	0.05	94.44	0.0077
E4 自我管理	4.61±0.61	0.13	66.67	0.0443
E4.1 具备自我保护意识	4.39±0.78	0.18	55.56	0.0074
E4.2 合理规划时间以确保每位失智老年人都能得到适当的关注和照护	4.61±0.70	0.15	72.22	0.0129
E4.3 严格要求自己,自我监督,不弄虚作假	4.06±0.80	0.20	33.33	0.0165
E4.4 能够在自身无法解决问题时及时求助外界的帮助	4.28±0.75	0.18	44.44	0.0067

人护理员“显性”胜任力的具体规定。在本研究构建的评价模型中,一级指标按权重大小排序依次为:专业技能、通用能力、职业素养、个人特质与理论知识。其中,专业技能的权重系数高达 0.2860,显著超越其他指标,构成了失智老年人护理员最核心的照护胜任力。作为直面失智老年人复杂照护需求的应用型人才,护理员精湛的专业技能不仅是其从业的基础,更是保障失智老年人生活质量、提升照护效果的关键所在^[30]。相较于既往养老机构护理员照护胜任力评价体系中专业技能这一维度的笼统划分^[19],本研究将专业技能维度细分为生活照护技能、精神行为症状护理技能和康复照护技能 3 项指标,以便更精准地对接失智老年人的实际照护需求。研究表明,约 9 成失智老年人在病程中会出现至少一种精神行为症状,而在养老机构中,该现象的发生率甚至攀升至 92%^[31]。因此,掌握精神行为症状的护理技能对失智老年人护理员而言至关重要。这项能力不仅能增强护理员的照护信心与积极态度,还有助于减缓失智老年人精神行为症状的发生频率,从而显著改善失智老年人的生活质量和心理状态^[32]。

3.3 隐形要素“通用能力”和“职业态度”等在失智老年人护理员照护胜任力中不可忽视

通用能力和职业态度分别位列一级指标权重排序的第 2 位和第 3 位,是失智老年人护理员在养老机构中必不可少的照护胜任力。这充分展现了冰山模型的指导思想,即通用能力、态度、价值观等隐性要素与个人长期工作表现相关,对员工胜任力的影响是关键性的^[33]。其中,通用能力作为识别岗位需要的关键能力^[34],是护理员在养老机构内从事失智老年人照护工作所需的首要隐形胜任力。本研究将通用能力划分为沟通能力、思维能力、协作能力和学习能力 4 项指标,这与宋雪雁等人的划分结果具有相似性^[35]。但与其研究不同的是,本研究强调了沟通能力的重要性,主要原因在于失智症的一个核心症状便是语言能力的退化,失智老年人常表现为词语遗忘、语句混乱,甚至完全失去表达能力^[36]。此外,失智老年人对他人语言的理解能力也会受损。这导致了一个巨大的困境,即需求无法被表达,关爱无法被接收。在这种情况下传统的语言沟通常常失效。因此,在养老机构中,护理员的沟通能力需要超越简单的对话,升华为一种集语言、非语言、情感和共情于一体的综合性艺术。而这种沟通能力,也正是衡量一个失智老年人护理员是否优秀的黄金标准。职业态度作为决定个体工作能力的关键因

素^[37],能够直接影响失智老年人护理员的照护水平。本研究中职业态度包含角色定位、职业道德和职业礼仪 3 项指标。其中角色定位在 17 项二级指标权重排序中排名第 3 位,而在 11 项隐形胜任力的二级指标权重排序中则位列第 1 位,表明角色定位对于失智老年人护理员而言至关重要。在传统观念中,护理员的角色常被简单等同于“保姆”或“护工”,其工作内容常被看作是喂饭、穿衣、洗澡等基础生活照料^[38]。然而,对于失智老年人护理员而言,这种定位可能过于片面。失智症是一种复杂的、进行性的脑部退行性疾病,它剥夺的不仅仅是老年人的记忆,还包括认知、情感、行为和人格^[39]。因此,失智老年人护理员这一角色必须被重新定义和精准定位,他们不仅是失智老年人与外界沟通的桥梁,还是混乱世界中的秩序维护者、更是尊严与情感的守护者。一个清晰、专业的角色定位,是提供高质量失智症照护的基石。

综上,本研究综合理论研究、文献分析、质性访谈、德尔菲法和层次分析法,构建了一套唐山市养老机构失智老年人护理员照护胜任力评价指标体系。该指标体系具有较强的权威性和可靠性,全面反映了失智老年人护理员在履行岗位职责时应具备的各项能力与素质,可为机构管理者制定失智老年人护理员的选拔、培训与发展策略方面提供参考依据。但本研究尚存在一定的局限性,受时间和人力等客观因素影响,未能开展实证研究,未来将就指标制定详细的评价标准及进行养老机构实践应用,以进一步验证和完善评价指标体系。

参考文献

- [1] MCCLELLAND D C. Testing for competence rather than for "intelligence" [J]. American Psychologist, 1973, 28(1): 1-14.
- [2] SPENCER I M, SPENCER S M. Competence at work: models for superior performance [M]. New York: Wiley, 1993.
- [3] 李培艺, 杨燕琳, 文进, 等. 我国互联网诊疗医生胜任力评价指标体系构建[J]. 医学与社会, 2023, 36(11): 82-87.
- [4] 金俊, 王丽, 周珍萍, 等. 基于 WHO 康复胜任力架构构建肿瘤科护理人员胜任力评价指标体系[J]. 中国医院, 2025, 29(7): 52-55.
- [5] 洪晓梅, 李跃平, 纪晴, 等. 口腔执业助理医师岗位胜任力模型构建[J]. 医学与社会, 2022, 35(1): 67-71.
- [6] GAUTHIER S, ROSA - NETO P, MORAIS J A. World Alzheimer report 2021: journey through the diagnosis of dementia [R]. London: Alzheimer's Disease International, 2021.

- [7]TERUM T M,TESTAD I,RONGVE A,et al. The association between aspects of carer distress and time until nursing home admission in persons with Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies [J]. International Psychogeriatrics,2021,33(4):337-345.
- [8]NICHOLS E,SZOEKE C E I,VOLLSET S E,et al. Global, regional, and national burden of Alzheimer's disease and other dementias,1990-2016:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016[J]. The Lancet Neurology,2019,18(1):88-106.
- [9]钟琴,鲍梦婕,徐义勇,等. 失智老年人分级照护标准研究进展[J]. 护理研究,2025,39(4):669-673.
- [10]GBD 2019 Dementia Forecasting Collaborators. Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J].Lancet Public Health,2022,7(2):105-125.
- [11]冷敏敏,孙月,鲁卫华,等. 失智照护领域知识图谱的构建[J]. 中华护理杂志,2024,59(4):432-438.
- [12]廖露露,何笑笑,杨玲花,等. 养老护理员优质照护行为量表的编制及信效度检验[J]. 护理学杂志,2025,40(5):74-78.
- [13]杜鹏,董亭月. 老龄化背景下失智老年人的长期照护现状与政策应对[J]. 河北学刊,2018,38(3):165-170.
- [14]赵凌波,曹文丽. 养老机构失智症照护人员职业能力评价体系构建[J]. 护理学报,2022,29(7):27-31.
- [15]WILLIAMS C L,HYER K,KELLY A,et al. Development of nurse competencies to improve dementia care[J]. Geriatr Nurs,2005,26(2):98-105.
- [16]HARRISON D K,SCATES C,MCGILL G,et al. A training needs analysis of admiral nurses to facilitate advance care planning in dementia[J]. Palliat Care,2019,12(1):127.
- [17]TRAYNOR V,INOUE K,CROOKES P. Literature review: understanding nursing competence in dementia care [J]. Journal of Clinical Nursing,2011,20(13-14):1948-1960.
- [18]王瑶,LILY D,陈嘉,等. 医护人员老年性痴呆照护胜任力[J]. 中国老年学杂志,2016,36(9):2284-2286.
- [19]杨丽,张京慧,徐彬斌,等. 医养结合视角下初级养老护理员胜任力模型的构建[J]. 中南大学学报(医学版),2018,43(6):679-684.
- [20]栾伟,曹莹,唐文娟,等. 基于行为事件访谈法及专家咨询法的医疗护理员胜任力模型研究[J]. 护理学杂志,2022,37(4):59-63.
- [21]达朝锦,黄延锦,卢玉彬,等. 基于互联网招聘信息挖掘的养老护理员岗位胜任力分析[J]. 护理学杂志,2023,38(8):58-62.
- [22]WATSON J D,CRICK F H. Molecular structure of nucleic acids;a structure for deoxyribose nucleic acid[J].Nature,1953,171(4356):737-738.
- [23]周娟,刘东玲,洪丽,等. 基于冰山模型的消毒供应中心管理者岗位胜任力评价量表编制及信效度检验[J]. 中华医院感染学杂志,2025,35(19):3005-3009.
- [24]宋晓霞,吴洪儒,白玉兴,等. 北京市三甲医院办公室主任岗位胜任力体系构建研究[J]. 医学与社会,2022,35(5):130-134.
- [25]苏嘉清,王碧艳,周俊杰,等. 医养结合型养老机构院长岗位胜任力评价指标体系构建研究[J]. 医学与社会,2022,35(4):74-78.
- [26]苏雪,程丽,蒲晓芳,等. 零售药店执业药师岗位胜任力评价双螺旋模型构建[J]. 中国药房,2024,35(16):2027-2032.
- [27]蔡爱丽. 高职院校专业课教师课程思政胜任力双螺旋模型构建[J]. 中国职业技术教育,2021(8):79-84.
- [28]张梅,黄伶俐,尹淙禹,等. 基层养老机构护理员认知障碍症照护胜任感现状及影响因素[J]. 护理研究,2024,38(15):2782-2786.
- [29]程巧玲,杨婷婷,任笑涵,等. 基于柯氏模型的河南省营养专科护士培训效果评价指标体系构建[J]. 医学与社会,2025,38(4):138-144.
- [30]苏婷,王宁,王丽洁,等. 老年认知症护理员核心能力指标体系的构建[J]. 护理学报,2023,30(14):13-17.
- [31]齐敬晗,倪翠萍,秦雨,等. 养老护理员开展失智症精神行为症状照护的护理培训[J]. 解放军护理杂志,2022,39(1):81-84.
- [32]COOKE M,MOYLE W,VENTURTO L,et al. Evaluation of an education intervention to implement a capability model of dementia care [J]. Dementia (London), 2014, 13 (5): 613-625.
- [33]张舜端,刘书君,龙翔凌,等. 我国公立医院科室运营助理岗位胜任力评价指标体系构建研究[J]. 医学与社会,2025,38(2):124-130.
- [34]陈子晨,姜鹤. 心理健康服务的文化胜任力:理论取向与实践策略[J]. 心理科学进展,2020,28(4):661-672.
- [35]宋雪雁,李溪萌,邓君. 数字时代档案文献编纂人员胜任力模型研究[J]. 图书情报工作,2020,64(3):32-41.
- [36]刘红艳. 阿尔茨海默症患者语言障碍研究现状和进展——基于病理语言学的实验研究综述[J]. 外语电化教学,2020(5):72-78.
- [37]陈曲,齐士格,王志会,等. 中国社区老年心理健康服务人员岗位胜任力及其影响因素分析[J]. 中国公共卫生,2025,41(4):406-410.
- [38]沈锦浩,方琼. 从嵌入到整合:医疗护理员职业化的挑战与出路[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2025(7):134-146.
- [39]许丁昕,王婧,LILY D. 世界卫生组织失智症照顾者 iSupport 项目研究进展[J]. 中国老年学杂志,2024,44(24):6122-6127.

(收稿日期 2025-11-10; 编辑 韩丹妮)